

LONG TERM CARE IN TRASFORMAZIONE: CASA, SERVIZI E COMUNITÀ

**UNA PROSPETTIVA EUROPEA
SUI MODELLI DI SERVIZIO POSSIBILI.**

Presentazione dell'8° Rapporto
Osservatorio Long Term Care

6 maggio 2026



**Università
Bocconi**

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

SDA Bocconi
SCHOOL OF MANAGEMENT

LONG TERM CARE IN TRASFORMAZIONE: CASA, SERVIZI E COMUNITÀ

SALUTI DI BENVENUTO

Elisabetta Notarnicola e Massimo Minaudo

Presentazione dell'8° Rapporto
OSSERVATORIO LONG TERM CARE



Università
Bocconi

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

SDA Bocconi
SCHOOL OF MANAGEMENT

Un ringraziamento alle aziende che hanno partecipato ai lavori 2025-2026, 8° edizione Osservatorio LOnG Term Care

- ASC Cremona Solidale
- ASP Golgi Redaelli
- ASP Bologna
- ASP Parma
- ASP Umberto Primo
- Assistiamo Casa Srl
- Cidas Società Cooperativa Sociale
- CODESS Società Cooperativa Sociale
- Consorzio Kursana, Gruppo Dussman
- Cooperativa Quadrifoglio
- Cooperativa Sana
- Cooperativa Sociale CADIAI
- Cooperativa sociale Coopselios
- Cooperativa Sociale Società Dolce
- Cooperativa Socioculturale
- Provincia Religiosa di San Marziano di don Orione
- Piccolo Cottolengo di Milano
- EnEA
- EMMAUS S.r.l.
- Fondazione Casa Cardinale Maffi Onlus
- Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus
- Fondazione Elisabetta Germani Onlus
- Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus
- Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus
- Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus
- Gruppo Colisée
- Gruppo Gheron
- Gruppo Zaffiro
- IPAV – Istituzioni Pubbliche di Assistenza Veneziane
- Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi Onlus
- Istituto Cav. Francesco Menotti – Onlus
- Istituto La Provvidenza
- KCS Caregiver Cooperativa Sociale
- Korian
- KOS Care
- PROGES Scarl
- Provincia Lombardo Veneta Fatebenefratelli
- Punto Service Società Cooperativa Sociale
- Gruppo SPES



**Università
Bocconi**

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

SDA Bocconi
SCHOOL OF MANAGEMENT

**10.20 IL SETTORE LONG TERM CARE
IN ITALIA NELLA FOTOGRAFIA
DELL'8° RAPPORTO OLTC**

ELEONORA PEROBELLI, SDA Bocconi
School of Management

**10.40 AMBITI DI INNOVAZIONE
POSSIBILE.**

**IPOTESI DI CAMBIAMENTO E
METODO DI RICERCA.**

ELISABETTA NOTARNICOLA,
SDA Bocconi School of Management
SIMONE MANFREDI, SDA Bocconi
School of Management

11.20 COFFEE BREAK

**11.50 DOVE SI GIOCA L'INNOVAZIONE
DEI MODELLI DI SERVIZIO?
LEZIONI DALLE ESPERIENZE
INTERNAZIONALI.**

ANDREA ROTOLO, SDA Bocconi School
of Management
MARIA VITTORIA BUFALI, SDA Bocconi
School of Management

**12.30 COSA SERVE PER INNOVARE I
SERVIZI LONG TERM CARE OGGI?
IL PUNTO DI VISTA DEGLI ESPERTI.**

DRAGANA CUROVIC, Project Manager
Bosocial, Helsingborgshem
MARIUCCIA ROSSINI, Presidente,
Silver Economy Network e Over
RANIERI ANTONIO ZUTTON, Direttore
Servizio Area Welfare di Comunità,
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Modera: **FRANCESCO LONGO**, Università
Bocconi

**13.10 PUNTI FERMI E AMBITI DI
SPERIMENTAZIONE PER AFFRONTARE
LE CRITICITÀ DELLA LONG TERM CARE.**

GIOVANNI FOSTI, SDA Bocconi School
of Management

SEGUIRÀ LIGHT LUNCH



Università
Bocconi

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

SDA Bocconi
SCHOOL OF MANAGEMENT

LONG TERM CARE IN TRASFORMAZIONE: CASA, SERVIZI E COMUNITÀ

**IL SETTORE LONG TERM CARE IN ITALIA
NELLA FOTOGRAFIA DELL'8° RAPPORTO OLTC**

Eleonora Perobelli

**Presentazione dell'8° Rapporto
OSSERVATORIO LONG TERM CARE**



**Università
Bocconi**

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

SDA Bocconi
SCHOOL OF MANAGEMENT

Il fabbisogno di interventi per la non autosufficienza

4 milioni

over 65 non autosufficienti

2 su 3

tra gli over 85

Fascia di età	Prevalenza da Istat (2021)	Popolazione di riferimento (1.1.2023)	Stima
65-74	14,60%	6.913.692	1.009.399
75-84	32,50%	5.024.159	1.632.852
85 e più	63,80%	2.243.446	1.431.319



Università
Bocconi

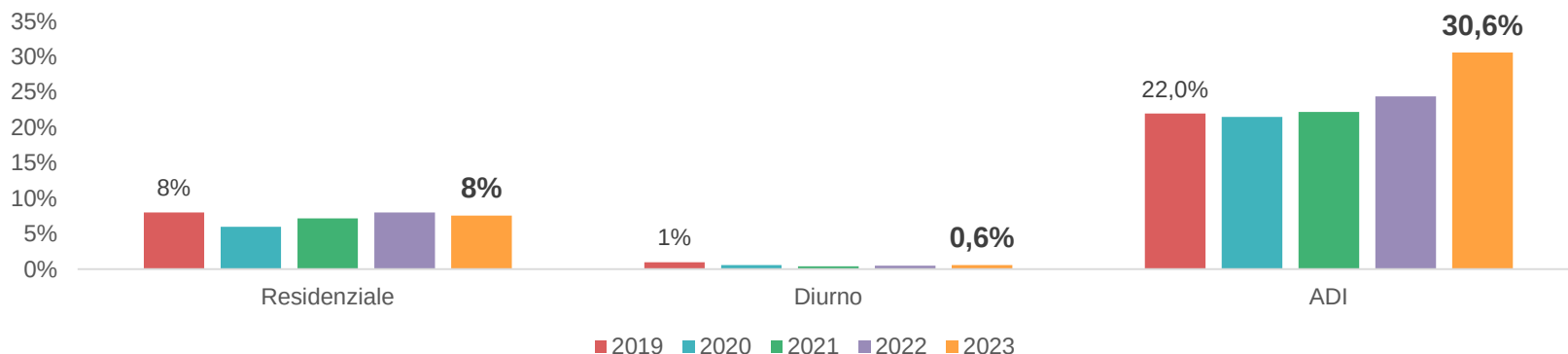
CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

SDA Bocconi
SCHOOL OF MANAGEMENT

Fonte: Elaborazione degli autori su dati Istat (più anni)

La rete di welfare pubblico lascia un ampio carico di cura alle famiglie:

% di 65+ Non autosufficienti che riceve servizi pubblici



39% è la quota dei 65+ non autosufficienti che ricevono servizi pubblici



Università
Bocconi

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

Fonte: elaborazioni autori su dati Annuario del SSN (più anni)

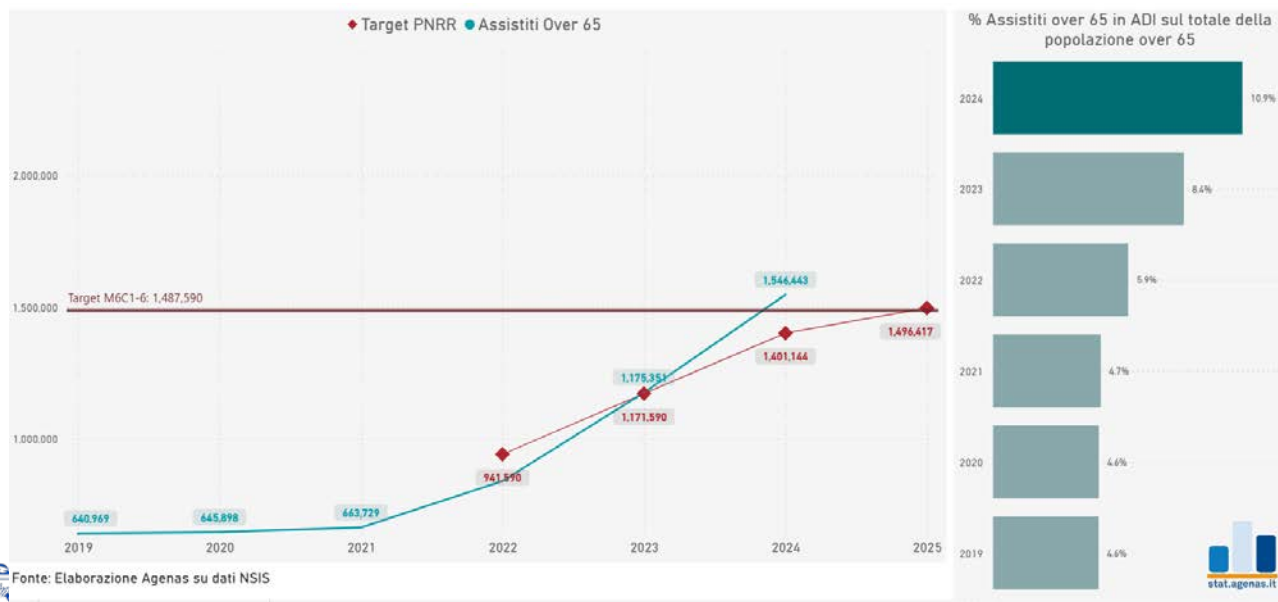
SDA Bocconi
SCHOOL OF MANAGEMENT

Assistenza domiciliare: **quo vadis?**

CON IL CONTRIBUTO DI



Abbiamo **raggiunto e superato** il target
PNRR, aumentando i casi in carico tramite ADI...



...ma le ore medie
per caso **sono diminuite**
da **16 (2021)** a **14 (2023)**



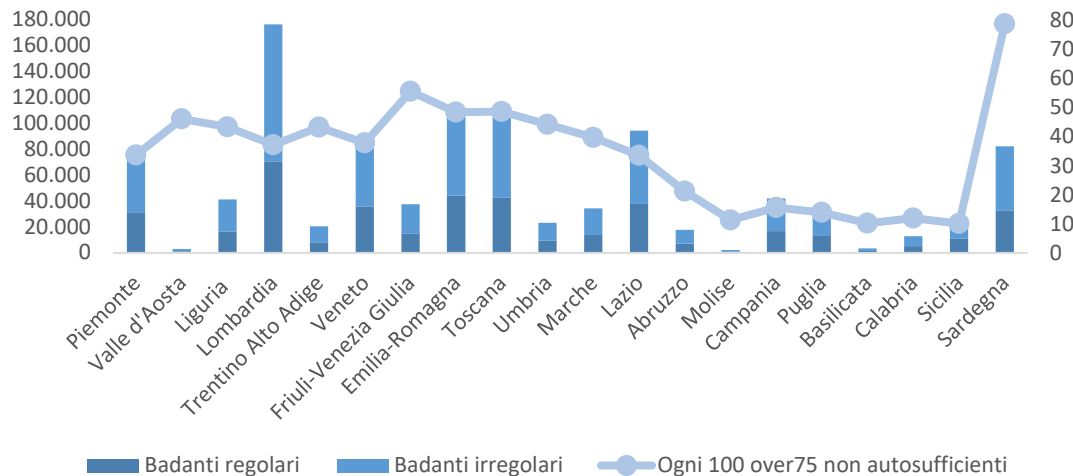
CERGIS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

Fonte: Cruscotto di monitoraggio Agenas (2025)

SDA Bocconi
SCHOOL OF MANAGEMENT

Intanto le famiglie si organizzano...

Numero badanti per regione e incidenza ogni 100 over75 N.A.



1+ milioni
di badanti totali

7,6 Mld. €
di spesa privata



Università
Bocconi

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

Fonte: elaborazioni autori su dati INPS (2025) e Osservatorio Domina (2025)

SDA Bocconi
SCHOOL OF MANAGEMENT

I gestori dei servizi: concentrati sul business model tradizionale

CON IL CONTRIBUTO DI



Fatturato 2025, in media:

88%

Da servizi
accreditati
(87% nel 2022)

61%

Da servizi
residenziali
per anziani
(56% nel 2022)

Di cui:

54% fin pubblico

34% compartecipazione

12% spesa privata su pl non accreditati

83%

dei gestori è attivo con
RSA, diurno e ADI



Università
Bocconi

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

Fonte: 17 gestori aderenti a OLTG; 34 gestori per dati su filiera

SDA Bocconi
SCHOOL OF MANAGEMENT

In un contesto in cui il sistema è sotto pressione, rileviamo la **contrazione della spesa pubblica**

CON IL CONTRIBUTO DI



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Spesa LTC pubblica in % sul PIL	1,25	1,30	1,43	1,37	1,28	1,20	1,18

<i>Spesa pubblica LTC per componenti:</i>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Componente sanitaria per LTC	0,46%	0,48%	0,55%	0,52%	0,47%	0,42%	0,43%
Indennità di accompagnamento	0,60%	0,60%	0,65%	0,60%	0,56%	0,53%	0,53%
"Altre prestazioni LTC"	0,19%	0,22%	0,23%	0,25%	0,28%	0,25%	0,22%
Totale	1,25%	1,30%	1,43%	1,37%	1,28%	1,20%	1,18%



Università
Bocconi

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

Fonte: Rapporto Ragioneria Generale dello Stato (2025)

SDA Bocconi
SCHOOL OF MANAGEMENT

Nell'attesa di vedere i primi frutti della **Riforma Anziani**

2024



DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2024, n. 29

Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33. (24G00050) (GU Serie Generale n.65 del 18-03-2024)

note: **Entrata in vigore del provvedimento: 19/03/2024**

Posticipo emanazione decreti con criteri di
accesso PUA e Valutazione
Multidimensionale per il PAI

Sperimentazioni rimandate a **gennaio 2027**



**Università
Bocconi**

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

2025



TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1 dicembre 2025, n. 200

Testo del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 200 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 302 del 31 dicembre 2025), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2026, n. 26 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.», (26A01010) (GU Serie Generale n.49 del 28-02-2026)

L'esigenza di ripensare il settore LTC italiano

CON IL CONTRIBUTO DI



1. Welfare pubblico sempre più residuale, popolazione sempre più anziana



L'esigenza di ripensare il settore LTC italiano

CON IL CONTRIBUTO DI



1. Welfare pubblico sempre più residuale, popolazione sempre più anziana

2. Badantato non ha alternativa, PNRR occasione persa per ripensare ADI



L'esigenza di ripensare il settore LTC italiano

CON IL CONTRIBUTO DI



1. Welfare pubblico sempre più residuale, popolazione sempre più anziana

2. Badantato non ha alternativa, PNRR occasione persa per ripensare ADI

3. Gestori «conservativi» e concentrati su singoli setting (residenziali)



L'esigenza di ripensare il settore LTC italiano

CON IL CONTRIBUTO DI



1. Welfare pubblico sempre più residuale, popolazione sempre più anziana

2. Badantato non ha alternativa, PNRR occasione persa per ripensare ADI

3. Gestori «conservativi» e concentrati su singoli setting (residenziali)

4. Guardare oltre, guardare fuori per ispirare nuove pratiche: casa e tech

LONG TERM CARE IN TRASFORMAZIONE: CASA, SERVIZI E COMUNITÀ

**AMBITI DI INNOVAZIONE POSSIBILE
IPOTESI DI CAMBIAMENTO E METODO DI RICERCA**

Elisabetta Notarnicola

**Presentazione dell'8° Rapporto
OSSERVATORIO LONG TERM CARE**



**Università
Bocconi**

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

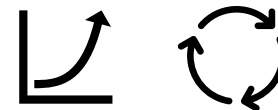
SDA Bocconi
SCHOOL OF MANAGEMENT

Il punto di partenza: un welfare «implicitamente» selettivo e la crisi dei modelli assistenziali

I nodi critici
del sistema
attuale LTC

- Sistema pubblico **limitato** nella capacità di risposta ai bisogni
- Famiglie che costruiscono **soluzioni “artigianali”**
- **Disallineamento strutturale** tra bisogni e offerta
- **Crisi del personale** e delle professioni
- Difficile **sostenibilità** dei servizi, dei gestori e del sistema

Non è più solo un problema di **quanto** il welfare riesca a fare, ma di **cosa** offra



Università
Bocconi

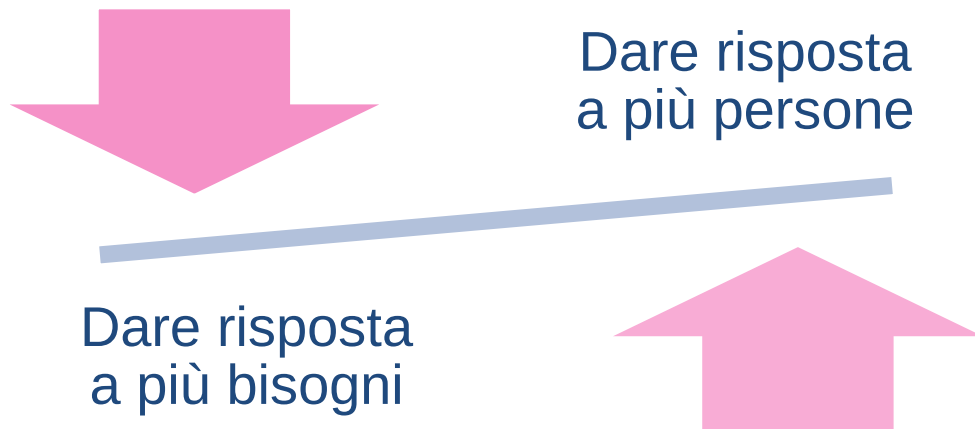
CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

Fonti:

8° Edizione Rapporto OLTC

Spasova, S., Baeten, R., & Vanhercke, B. (2018). Challenges in long-term care in Europe. *Eurohealth*, 24(4), 7-12.

Le due sfide dell'innovazione: modelli di servizio al bivio



I modelli di servizio possono
essere innovati secondo
logiche che tengano conto
di questi due driver?



Università
Bocconi

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

La rottura di paradigma: da sistema rigido a sistemi flessibili

Oggi:

Prestazioni

Singoli setting di servizio

Diversi canali di finanziamento

Ruoli rigidi e separati

Domani:

Soluzioni

Servizi flessibili e connessi

Attivazione di risorse multiple e integrate

Ricerca attiva di reti e collaborazioni

Da un sistema rigido progettato per erogare prestazioni, a sistemi di servizio flessibili che generano valore diffuso



Università
Bocconi

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

Due ambiti di innovazione: leve strutturali per l'innovazione del sistema

Abitare e tecnologia piattaforme abilitanti:

Definiscono il
contesto in cui
viene erogato il
servizio

Abilitano nuove
caratteristiche
core e
accessorie

Modificano le
relazioni, le reti e il
modo in cui si attivano
gli attori

Connessione, integrazione, flessibilità



Università
Bocconi

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

Perché guardare al contesto internazionale?

Focus:

- Sui modelli di servizio
- Sui processi di innovazione
- Sulle condizioni abilitanti
- Sulla sostenibilità nel tempo

Problemi e soluzioni sono validi anche dentro sistemi di regole, culturali e organizzativi diversi.

Cerchiamo nella diversità strade comuni



Università
Bocconi

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

LONG TERM CARE IN TRASFORMAZIONE: CASA, SERVIZI E COMUNITÀ

**AMBITI DI INNOVAZIONE POSSIBILE
IPOTESI DI CAMBIAMENTO E METODO DI RICERCA**

Simone Manfredi

**Presentazione dell'8° Rapporto
OSSERVATORIO LONG TERM CARE**



Università
Bocconi

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

SDA Bocconi
SCHOOL OF MANAGEMENT

MAPPATURA DI CASI INTERNAZIONALI

SCOPO E PERIMETRO DEL LAVORO

La ricognizione di pratiche innovative nel settore LTC si è focalizzata su due particolari ambiti in cui si osservano **cambiamenti strutturali** abilitati dalle innovazioni, vere e proprie **piattaforme di cambiamento** con un impatto sistemico.



Soluzioni abitative innovative

- Con esplicita **componente** o **collegamento** a **servizi** sociosanitari o sanitari
- Soluzioni che compongono un **ecosistema** di servizi di **accompagnamento all'invecchiamento**



Tecnologie digitali per servizi al domicilio

- **Servizi** per persone anziane erogate **al domicilio abilitate da tecnologia digitale**.
- Soluzioni tecnologiche digitali che abilitino **ecosistemi** di servizi **per il supporto alla domiciliarità** o per l'assistenza al proprio domicilio



Università
Bocconi

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

MAPPATURA DI CASI INTERNAZIONALI

SCOPO E PERIMETRO DEL LAVORO



Soluzioni abitative innovative per persone anziane

DRIVER DEL FENOMENO

- Cambiamenti socio-demografici ed epidemiologici
- Crescente **pressione sui sistemi di LTC**
- Crisi del modello istituzionale tradizionale
- Preferenza per **Ageing in Place**

RIDEFINIRE IL CONCETTO DI ABITARE COME LEVA STRATEGICA PER LA SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA LTC

In Europa, sono sempre più diffusi **modelli** abitativi innovativi ed **ibridi** che si collocano **nel continuum** tra cure domiciliari tradizionali e la residenzialità istituzionale.



Università
Bocconi

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

MAPPATURA DI CASI INTERNAZIONALI

SCOPO E PERIMETRO DEL LAVORO



Tecnologie digitali per servizi al domicilio per persone anziane

DRIVER DEL FENOMENO

- Invecchiamento e aumento cronicità/multimorbilità
- Crescente domanda di LTC, ma risorse limitate
- **Carenza di forza lavoro** nel settore LTC
- Preferenza per **Ageing in Place**

TECNOLOGIE DIGITALI COME LEVA DI SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE DEI SISTEMI LTC

Tecnologie digitali che operano come **fattore “abilitante”** nella ridefinizione di ruoli, processi e modelli di gestione dei servizi di assistenza domiciliare.

- Decentralizzazione: spostamento **verso comunità/domiciliarità**
- **Superamento** di logiche a **silos**
- Da assistenza reattiva a **prevenzione** proattiva



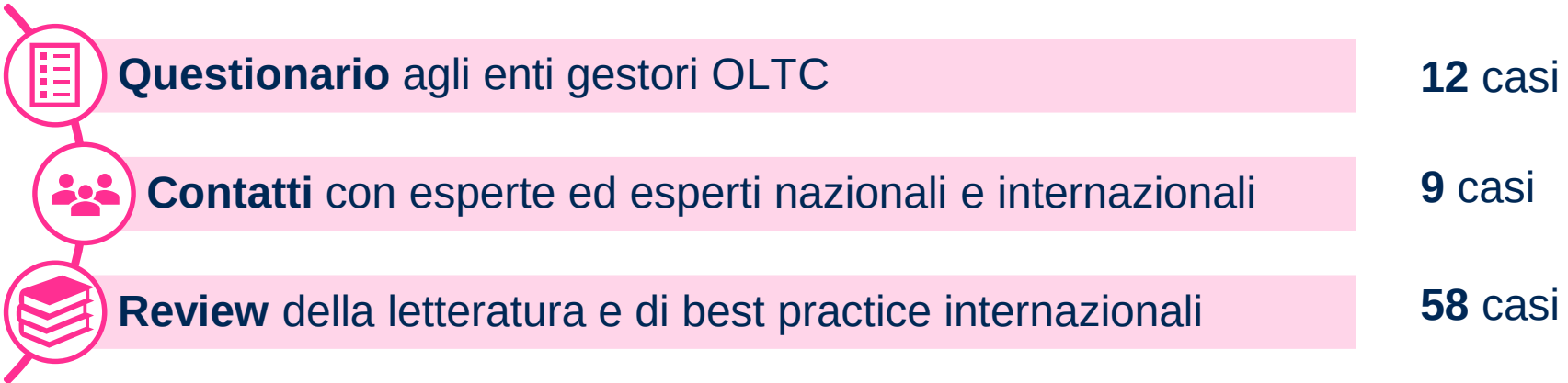
Università
Bocconi

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

MAPPATURA DI CASI INTERNAZIONALI

METODOLOGIA ED ESITI

Individuati **79 casi** studio in paesi europei tramite:



Università
Bocconi

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

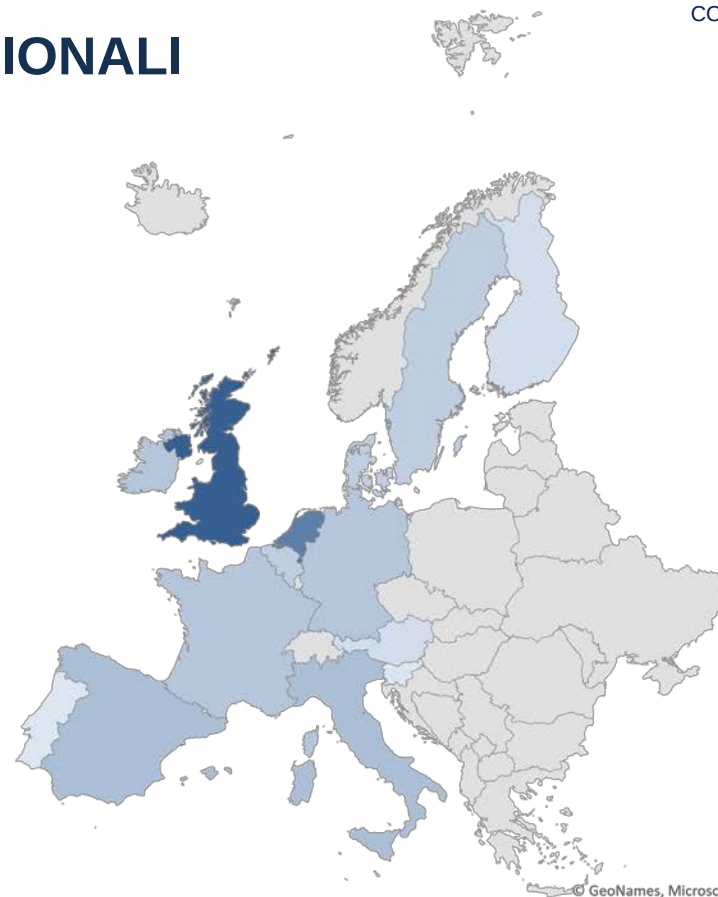
MAPPATURA DI CASI INTERNAZIONALI

METODOLOGIA ED ESITI

CON IL CONTRIBUTO DI



	Housing	Digital	Totale
Regno Unito	14	4	18
Paesi Bassi	11	3	14
Spagna	4	2	6
Italia	3	3	6
Germania	4	1	5
Francia	5	0	5
Irlanda	4	1	5
Svezia	3	1	4
Danimarca	3	1	4
Belgio	4	0	4
Internazionale	0	2	2
Finlandia	2	0	2
Austria	1	1	2
Slovenia	1	0	1
Portogallo	1	0	1
Totale	60	19	79



Università
Bocconi

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

Con tecnologia Bing
© GeoNames, Microsoft, Open Places, OpenStreetMap, TomTom

SDA Bocconi
SCHOOL OF MANAGEMENT

MAPPATURA DI CASI INTERNAZIONALI VERSO UNA TASSONOMIA DI MODELLI INNOVATIVI



Soluzioni abitative innovative per persone anziane

La review ha messo in evidenza **6 principali modelli** di intervento:

Dementia Villages, comunità dementia friendly

Vita comunitaria con servizi di supporto

Modelli cooperativi

Spazi abitativi intergenerazionali, home sharing

Rifugi di transizione, hotel per soggiorni prolungati

Assistenza infermieristica di quartiere



**Università
Bocconi**

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

MAPPATURA DI CASI INTERNAZIONALI VERSO UNA TASSONOMIA DI MODELLI INNOVATIVI



Soluzioni abitative innovative per persone anziane

La review ha messo in evidenza 6 modelli di intervento:

Dementia Villages, comunità dementia friendly

Vita comunitaria con servizi di supporto

Modelli cooperativi

Spazi abitativi intergenerazionali, home sharing

Rifugi di transizione, hotel per soggiorni prolungati

Assistenza infermieristica di quartiere

- 
- Riproduzione dell'ambiente di un **piccolo quartiere** o di reti territoriali community-based
 - **Vita quotidiana come terapia:** l'obiettivo è migliorare qualità della vita, autonomia residua e socialità, riducendo uso di farmaci



Università
Bocconi

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

MAPPATURA DI CASI INTERNAZIONALI VERSO UNA TASSONOMIA DI MODELLI INNOVATIVI



Soluzioni abitative innovative per persone anziane

La review ha messo in evidenza 6 modelli di intervento:

Dementia Villages, comunità dementia friendly

Vita comunitaria con servizi di supporto

Modelli cooperativi

Spazi abitativi intergenerazionali, home sharing

Rifugi di transizione, hotel per soggiorni prolungati

Assistenza infermieristica di quartiere

- 
- Soluzioni intermedie tra vita indipendente e residenzialità: **appartamenti privati all'interno di complessi** con spazi comuni e servizi
 - Coniugare autonomia, sicurezza e vita comunitaria, offrendo **servizi modulabili** in base all'**evoluzione dei bisogni**



Università
Bocconi

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

MAPPATURA DI CASI INTERNAZIONALI VERSO UNA TASSONOMIA DI MODELLI INNOVATIVI



Soluzioni abitative innovative per persone anziane

La review ha messo in evidenza 6 modelli di intervento:

Dementia Villages, comunità dementia friendly

Vita comunitaria con servizi di supporto

Modelli cooperativi

Spazi abitativi intergenerazionali, home sharing

Rifugi di transizione, hotel per soggiorni prolungati

Assistenza infermieristica di quartiere

- 
- Le persone anziane residenti sono **soci con diritto d'uso** dell'alloggio, promuovendo governance partecipata
 - Assistenza generalmente leggera, ma promozione di mutualità, **supporto reciproco** e prevenzione dell'isolamento tra pari



Università
Bocconi

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

MAPPATURA DI CASI INTERNAZIONALI VERSO UNA TASSONOMIA DI MODELLI INNOVATIVI



Soluzioni abitative innovative per persone anziane

La review ha messo in evidenza 6 modelli di intervento:

Dementia Villages, comunità dementia friendly

Vita comunitaria con servizi di supporto

Modelli cooperativi

Spazi abitativi intergenerazionali, home sharing

Rifugi di transizione, hotel per soggiorni prolungati

Assistenza infermieristica di quartiere

- 
- Convivenza o prossimità tra generazioni diverse, per **contrastare** la **solitudine** tramite solidarietà intergenerazionale.
 - Promuovono uso efficiente del patrimonio abitativo per contrastare la difficoltà di **accesso alla casa**



Università
Bocconi

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

MAPPATURA DI CASI INTERNAZIONALI VERSO UNA TASSONOMIA DI MODELLI INNOVATIVI



Soluzioni abitative innovative per persone anziane

La review ha messo in evidenza 6 modelli di intervento:

Dementia Villages, comunità dementia friendly

Vita comunitaria con servizi di supporto

Modelli cooperativi

Spazi abitativi intergenerazionali, home sharing

Rifugi di transizione, hotel per soggiorni prolungati

Assistenza infermieristica di quartiere

- 
- Alloggi con servizi alberghieri e assistenza sociosanitaria leggera per **periodi limitati**
 - Favorire il recupero dell'autonomia (post-ospedalizzazione, riabilitazione) ed **evitare ricoveri impropri o ritardare l'ingresso in strutture**



Università
Bocconi

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

MAPPATURA DI CASI INTERNAZIONALI VERSO UNA TASSONOMIA DI MODELLI INNOVATIVI



Soluzioni abitative innovative per persone anziane

La review ha messo in evidenza 6 modelli di intervento:

Dementia Villages, comunità dementia friendly

Vita comunitaria con servizi di supporto

Modelli cooperativi

Spazi abitativi intergenerazionali, home sharing

Rifugi di transizione, hotel per soggiorni prolungati

Assistenza infermieristica di quartiere

- 
- **Team** infermieristici auto-gestiti, **radicati in un territorio** definito
 - **Cure integrate** (sanitarie e sociali) direttamente al domicilio della persona, con un approccio centrato sulla **relazione con la persona**



Università
Bocconi

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

MAPPATURA DI CASI INTERNAZIONALI VERSO UNA TASSONOMIA DI MODELLI INNOVATIVI



Soluzioni abitative innovative per persone anziane

Alcuni principi trasversali delineano un paradigma comune di innovazione:

- **Centralità della persona** e co-produzione dei servizi: persona anziana è soggetto attivo
- **Governance partecipata** e flessibile (responsabilizzando sia utenti che professionisti)
- Dimensione domestica e micro-scala: **l'ambiente è dispositivo terapeutico**
- **Integrazione** con la comunità e prossimità ai servizi (approccio **anti-segregante**)



Università
Bocconi

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

SDA Bocconi
SCHOOL OF MANAGEMENT

MAPPATURA DI CASI INTERNAZIONALI VERSO UNA TASSONOMIA DI MODELLI INNOVATIVI



Tecnologie digitali per servizi al domicilio per persone anziane

4 principali scopi dell'uso di tecnologie:

Adattare la casa per favorire l'indipendenza

Gestire proattivamente la salute

Rendere i servizi più flessibili e orientati ai dati

Rafforzare la dimensione relazionale e di comunità



**Università
Bocconi**

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

SDA Bocconi
SCHOOL OF MANAGEMENT

MAPPATURA DI CASI INTERNAZIONALI VERSO UNA TASSONOMIA DI MODELLI INNOVATIVI



Tecnologie digitali per servizi al domicilio per persone anziane

4 principali scopi dell'uso di tecnologie:

Adattare la casa per favorire l'indipendenza

Gestire proattivamente la salute

Rendere i servizi più flessibili e orientati ai dati

Rafforzare la dimensione relazionale e di comunità

- 
- Le tecnologie abilitano un **ambiente “intelligente”** attraverso sensori di movimento, rilevatori di caduta e dispositivi di telecomunicazione
 - Sostenere l'autonomia quotidiana con un'assistenza “silenziosa” che attiva interventi solo in caso di anomalie, aumentando la **sicurezza** e prolungando la permanenza a casa



Università
Bocconi

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

MAPPATURA DI CASI INTERNAZIONALI VERSO UNA TASSONOMIA DI MODELLI INNOVATIVI



Tecnologie digitali per servizi al domicilio per persone anziane

4 principali scopi dell'uso di tecnologie:

Adattare la casa per favorire l'indipendenza

Gestire proattivamente la salute

Rendere i servizi più flessibili e orientati ai dati

Rafforzare la dimensione relazionale e di comunità

- 
- Dispositivi indossabili, sensori biometrici e piattaforme di monitoraggio permettono la raccolta e **analisi continua di dati**
 - Identificare precocemente segnali di rischio e **favorire interventi preventivi** e personalizzati



Università
Bocconi

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

MAPPATURA DI CASI INTERNAZIONALI VERSO UNA TASSONOMIA DI MODELLI INNOVATIVI



Tecnologie digitali per servizi al domicilio per persone anziane

4 principali scopi dell'uso di tecnologie:

Adattare la casa per favorire l'indipendenza

Gestire proattivamente la salute

Rendere i servizi più flessibili e orientati ai dati

Rafforzare la dimensione relazionale e di comunità

- 
- Piattaforme di care management, registri elettronici, strumenti di comunicazione e sistemi di analisi che supportano la **gestione dei provider**
 - Verso servizi più flessibili, trasparenti con un **migliore coordinamento** multidisciplinare e più efficienti con una **minore burocrazia**



Università
Bocconi

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

MAPPATURA DI CASI INTERNAZIONALI VERSO UNA TASSONOMIA DI MODELLI INNOVATIVI



Tecnologie digitali per servizi al domicilio per persone anziane

4 principali scopi dell'uso di tecnologie:

Adattare la casa per favorire l'indipendenza

Gestire proattivamente la salute

Rendere i servizi più flessibili e orientati ai dati

Rafforzare la dimensione relazionale e di comunità

- 
- Soluzioni di **digital outreach** (es. videochiamate, piattaforme di social engagement, centri diurni virtuali)
 - Creano un **ponte relazionale** tra persona anziana, caregiver, professionisti e comunità, contrastando isolamento e solitudine



Università
Bocconi

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

MAPPATURA DI CASI INTERNAZIONALI VERSO UNA TASSONOMIA DI MODELLI INNOVATIVI



Tecnologie digitali per servizi al domicilio per persone anziane

Le esperienze analizzate condividono tre elementi:

- **Tecnologia** è parte dell'innovazione dei **modelli organizzativi** (rendendoli più flessibili, prossimi e partecipati)
- **Governance basata su dati** e valutazione continua (sia per i provider di servizi che per i decisori pubblici)
- Attenzione al **coinvolgimento attivo** degli utenti affinché la tecnologia non sia una sostituzione della relazione umana, ma propedeutica al suo rafforzamento



Università
Bocconi

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

MAPPATURA DI CASI INTERNAZIONALI

CONSIDERAZIONI TRASVERSALI

-  Cambio di paradigma: da servizio offerto a **servizio co-prodotto**
-  L'innovazione contribuisce alla costruzione di **ecosistemi integrati**
-  I cambiamenti strutturali richiedono **governance di sistema**



Università
Bocconi

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

SDA Bocconi
SCHOOL OF MANAGEMENT

LONG TERM CARE IN TRASFORMAZIONE: CASA, SERVIZI E COMUNITÀ

**UNA PROSPETTIVA EUROPEA
SUI MODELLI DI SERVIZIO POSSIBILI.**

Presentazione dell'8° Rapporto
Osservatorio Long Term Care

6 maggio 2026



**Università
Bocconi**

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

SDA Bocconi
SCHOOL OF MANAGEMENT

LONG TERM CARE IN TRASFORMAZIONE: CASA, SERVIZI E COMUNITÀ

**DOVE SI GIOCA L'INNOVAZIONE DEI MODELLI DI SERVIZIO?
LEZIONI DALLE ESPERIENZE INTERNAZIONALI**

Maria Vittoria Bufali

**Presentazione dell'8° Rapporto
OSSERVATORIO LONG TERM CARE**



Universit 
Bocconi

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

SDA Bocconi
SCHOOL OF MANAGEMENT

Casi di studio internazionali

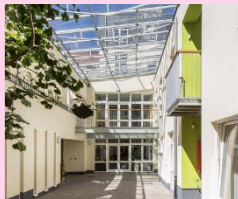
SällBo. Helsingborg, SE



Social living multi-generazionale e culturale



Maison Biloba. Bruxelles, BE



Senior living e centro diurno per persone fragili



Trygghetsboende. Helsingborg, SE



Senior housing leggero per persone over65



Thuisplusflats. Rotterdam, NL



Social living per persone anziane con servizi di cura



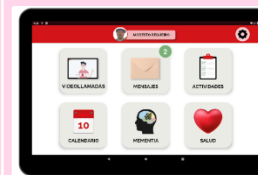
Home with care. Dublino, IE



Senior living per persone anziane con servizi di cura



etxeTIC. Biscaglia, ES



Centro diurno virtuale per persone anziane



Dagmarsminde. Græsted, DK



Small-scale living per persone con demenza



Università
Bocconi

CERGAS

Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

SDA Bocconi
SCHOOL OF MANAGEMENT

Casi di studio internazionali

SällBo. Helsingborg, SVEZIA



Social living multigenerazionale e culturale

Circa 50 appartamenti destinati a: ~60% **anziani** (65+/70+); ~40% **giovani adulti** (18–25), in parte **rifugiati**

Obiettivo: contrastare **solitudine** e promuovere **integrazione**

Progettazione: workshop con gruppi target

Accesso: processo di selezione (diversità, motivazione, contributo a comunità)

Regole di convivenza (2h/sett socializzazione; meeting mensili)

Figura chiave: housing host/community manager

Servizi di cura attivati tramite welfare pubblico

Presenza di ampi spazi comuni per favorire interazione



Università
Bocconi

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

Casi di studio internazionali

SällBo. Helsingborg, SVEZIA

Elementi strategici

- **Modello ibrido** tra housing pubblico, senior housing e integrazione sociale
- Lo sviluppo del modello di servizio è partito dall'**analisi dei bisogni** e dalle priorità del territorio, nonché dalle **risorse disponibili** e ha previsto un processo di **co-design**.
- **Mix intenzionale di target** per massimizzare eterogeneità e generare mutuo aiuto.

Modello di finanziamento:

- Affitti calmierati ma non fortemente sovvenzionati (~400–540€/mese, incluse utenze)
- Investimento iniziale di Helsimborgshem (azienda comunale) per riqualificazione
- Ruolo housing host finanziato al 60% da risorse pubbliche
- Gestione del servizio in equilibrio (break-even raggiunto)



Università
Bocconi

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

SDA Bocconi
SCHOOL OF MANAGEMENT

Casi di studio internazionali

SällBo. Helsingborg, SVEZIA



Mix target e bisogni



Importanza selezione utenza



Ruolo Community Management



Processo di co-design e co-gestione



Bocconi

CERGAS

Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

Criticità emerse:

- Dipendenza da figure chiave (project leader e housing host)
- Condizioni per replicabilità: presenza di edifici adeguati, flessibilità istituzionale, possibilità di uscire da procedure standard

Casi di studio internazionali

Maison Biloba. Bruxelles, BELGIO



Senior living e centro diurno per persone fragili

15 unità abitative destinate a persone 60+ indipendenti, ma con importanti fragilità sociali

Un **centro diurno** aperto alla cittadinanza (dal 2009)

CitiSen (dal 2018), una rete locale di informazione e mutuo aiuto composta da quattro luoghi di incontro («alveari»)



Obiettivo: fornire soluzioni abitative accessibili per consentire l'**ageing in place**, fornendo al contempo **aiuto alla navigazione** e al reperimento di soluzioni locali in risposta ai bisogni espressi.

Selezione in coordinamento con Serv. sociali e Foyer Schaerbeekoïse
Figura chiave: facilitatore di comunità (assistente sociale)



Università
Bocconi

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

SDA Bocconi
SCHOOL OF MANAGEMENT

Casi di studio internazionali

Maison Biloba. Bruxelles, BELGIO

Elementi strategici

- **Case management**, grazie ad assistente sociale dedicato a comunità residente (2024)
- **Raccordo con i servizi sanitari, sociosanitari e sociali** – Es. valutazione multiprofessionale dei bisogni («concertazione») e redazione del piano di assistenza
- **Permeabilità** con la comunità del quartiere, grazie a centro diurno

Modello di finanziamento:

- Centro diurno, accreditato con IRIScare (regione di Bruxelles)
- Housing sociale, finanziamento comunale per case management + SLRB (governo regionale)
- Rete CitiSen, contributi a progetto



Università
Bocconi

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

SDA **Bocconi**
SCHOOL OF MANAGEMENT

Casi di studio internazionali

Maison Biloba. Bruxelles, BELGIO



Accettare la dimensione sperimentale



Anticipare le richieste degli enti



Lavorare assieme alla comunità



Storytelling e identità del progetto



Bocconi

CERGAS

Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

Criticità emerse:

- Confini professionali tradizionali messi in discussione («coltellino svizzero»)
- Sistema di finanziamento frammentato, ancora non coerente con modelli ibridi e figure professionali emergenti
- Difficoltà di posizionamento, anche in termini di percezione pubblica (logo)

Casi di studio internazionali

Trygghetsboende. Helsingborg, SVEZIA



Modello di senior housing «leggero» (65+)

Appartamenti “ordinari” **adattati per l’invecchiamento**, rivolti a persone 65+ in condizione di autosufficienza, inseriti in complessi residenziali esistenti (non dedicati solo a senior)

Presenza di spazi comuni, attività sociali, figura di riferimento (host)



<https://helsingborgshem.se/artikel/trygghetsboend>

Obiettivo: prolungare autonomia al domicilio e offrire un ambiente più “sicuro” e socializzante; **colmare gap** tra vita indipendente e assistenza istituzionale.

Accesso: processo standard di assegnazione (no selezione «qualitativa»)

Organizzazione di attività sociali (fika, eventi, gite), aperte a quartiere

Ruolo chiave: housing host (supporto pratico «leggero» e relazionale, organizzazione attività, orientamento ai servizi)

Assistenza socio-sanitaria *dovrebbe* essere fornita dal pubblico



Università
Bocconi

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

Casi di studio internazionali

Trygghetsboende. Helsingborg, SVEZIA

Elementi strategici

- Il modello prevede la messa a disposizione di appartamenti di varie dimensioni, accessibili e con servizi di **supporto leggero come elemento accessorio**.
- Gli appartamenti vengono sottoposti ad **adattamenti strutturali** (accessibilità, sicurezza; con differenze a seconda della/e persone che andranno ad abitarci)
- Nel disegno del servizio, è previsto che l'azienda fornisca supporto per quanto riguarda la **dimensione sociale**, non quella socio-sanitaria e sanitaria (in capo ai Comuni)

Modello di finanziamento:

- Gli inquilini pagano un affitto standard (allineato al mercato locale)
- È previsto un costo aggiuntivo limitato per i servizi



Università
Bocconi

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

SDA **Bocconi**
SCHOOL OF MANAGEMENT

Casi di studio internazionali

Trygghetsboende. Helsingborg, SVEZIA



Coerenza con policy esistenti (non bottom-up)



Sistema di welfare e patrimonio edilizio sviluppati



Innovazioni incrementali

Criticità emerse:

- Persone entrano nel modello troppo tardi (già fragili)
- Mismatch tra design del servizio e utenti reali
- Dispersione spaziale
- Difficoltà di engagement degli anziani più fragili
- Aspettative distorte (confuso con nursing home) e host che operano fra responsabilità formali e interventi informali



**Università
Bocconi**

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

Casi di studio internazionali

Thuisplusflats. Rotterdam, PAESI BASSI



Social living per persone anziane con servizi di cura

20 complessi (da almeno 80 unità abitative) che ospitano persone di età 55+ (priorità data agli over 65) con **bisogni di assistenza lieve**.

Obiettivo: Supplire a **mancaanza di soluzioni intermedie** tra la vita al domicilio (eventualmente con servizi di assistenza domiciliare) e le strutture residenziali con assistenza intensiva.



Spazi comuni: ospitano attività educative, di prevenzione e socio-ricreative organizzate con il supporto di un «well-being coordinator».

Ruolo chiave: coordinatori di comunità + team multidisciplinare di professionisti in loco (assistenza sociosanitaria gestione degli alloggi, monitoring continuo) + infermerie di quartiere (walk-in sessions periodiche)

Componente digitale: piattaforma digitale per monitorare prestazioni e bisogni



Università
Bocconi

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

SDA Bocconi
SCHOOL OF MANAGEMENT

Casi di studio internazionali

Thuisplusflats. Rotterdam, PAESI BASSI

Elementi strategici

- Strutture con almeno 80 appartamenti, spazi comuni e **entro 500 metri da TPL e servizi**
- **Gestione congiunta:** gestore di servizi di assistenza + gestore housing sociale (mix)
- **Unico gestore** di servizi di assistenza per complesso (accreditato per WMO, ZVW, WLZ)
- **Mappatura** delle capacità dei residenti e della loro disponibilità a contribuire

Modello di finanziamento:

- Affitto calmierato, secondo le regole dell'housing sociale (ca. 700 €/mese)
- Assistenza, secondo gli schemi standard WMO, ZVW e WLZ
- Contributo comunale per promuovere il modello: 58.500 € (+ 19.500 €) /anno per complesso, con incentivi relativi a performance (mix utenza, efficienza coordinamento)



Università
Bocconi

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

SDA **Bocconi**
SCHOOL OF MANAGEMENT

Casi di studio internazionali

Thuisplusflats. Rotterdam, PAESI BASSI



Riorganizzazione di servizi esistenti



Governo delle sinergie (incentivi)



Valorizzazione dei ruoli professionali



Équipe multidisciplinari e complementari

Criticità emerse:

- Logiche ed incentivi istituzionali confliggenti
- Disallineamento tra costi e benefici: Il modello riduce l'impatto sul budget LTC (posticipando e riducendo il ricorso ai servizi sociosanitari residenziali), ma lo aumenta per l'assistenza sociale a carico del Comune, rendendo necessarie azioni di advocacy.



Università
Bocconi

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

Casi di studio internazionali

Home with Care. Dublino, IRLANDA



Senior living per persone anziane con servizi di cura

2 strutture che possono ospitare complessivamente **112 persone** anziane (anche con demenza lieve o moderata)

Obiettivo: offrire **spazi abitativi non clinici** a persone che non necessitano di assistenza ad alta intensità, ma che non possono più rimanere in sicurezza nelle proprie abitazioni + facilitare il reperimento di una soluzione abitativa adatta ai propri bisogni **senza sradicamento**

Offerta di una soluzione abitativa accessibile con supporto assistenziale 24/h

Attività di socializzazione negli spazi comuni e centri diurni presenti

Figure chiave: team qualificati che includono: manager (con background di studi in social work e formazione specifica in management); 1 team leader + 4 senior care worker (ratio 1:10 e 1:5)

Quando richiesto, è attivato il servizio infermieristico domiciliare pubblico.



Università
Bocconi

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

SDA Bocconi
SCHOOL OF MANAGEMENT

Casi di studio internazionali

Home with Care. Dublino, IRLANDA

Elementi strategici

- **Cambiamento culturale:** anticipare la scelta del cambio dell'abitazione ai 60-65 anni, il momento più appropriato per il mantenimento dell'autonomia nel lungo periodo, anche all'insorgenza di condizioni di non autosufficienza lieve e moderata.
- **Mix di tipologie abitative:** sfruttare gli sviluppi normativi relativi alla pianificazione urbana (edilizia sociale mista e quote destinate a senior) evitano che la persona debba sradicarsi dal quartiere (in ottica «ageing in place»).

Modello di finanziamento:

- Residenti: affitto calmierato (110 €/settimana) + quota per assistenza (70 €/settimana)
- Health Service Executive: contributo per assistenza 645 €/settimana



Università
Bocconi

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

SDA Bocconi
SCHOOL OF MANAGEMENT

Casi di studio internazionali

Home with Care. Dublino, IRLANDA



Innovare anche nella rigidità normativa



Esplicitare il valore pubblico



Investire in alleanze strategiche



Complementare servizi e risorse



Università
Bocconi

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

Criticità emerse:

- Assenza di riferimenti normativi e standard (es. dotazione personale) specifici
- Assenza di cicli di finanziamento pluriennali (cruciali per garantire la stabilità e consentire ai fornitori di migliorare le condizioni del personale e investire nell'innovazione)

Casi di studio internazionali

etxeTIC. Biscaglia, SPAGNA



Centro diurno virtuale per persone anziane

Servizio **pubblico e gratuito di supporto alla domiciliarità**, basato su tecnologia e assistenza ibrida

Attualmente offerto da **11 centri privati** (selezionati con gare di appalto pubbliche), raggiunge circa **2.800 nuclei familiari**

Obiettivo: prolungare la permanenza al domicilio, prevenire istituzionalizzazione, isolamento e burden carer

Assessment geriatrico per PAI (rivisto periodicamente)

Accesso a calendario attività e contenuti multimediali

Dashboard per monitorare performance

Messaggistica e video call (1-1, gruppo)

Ruolo chiave: case manager + team multidisciplinari + coordinatore del Dipartimento dei Servizi Sociali



Università
Bocconi

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

SDA Bocconi
SCHOOL OF MANAGEMENT

Casi di studio internazionali

etxeTIC. Biscaglia, SPAGNA

Elementi strategici

- **Architettura di servizio ibrida:** combinazione di centri fisici con una forte componente digitale che estende la cura all'interno delle abitazioni degli utenti.
- **Modello scalabile:** parzialmente vincolato a infrastruttura fisica, così che, con il costo di un centro diurno che servirebbe 50 persone, ne raggiungo 400+(fra utenti e carer)
- **Complementarietà** ai servizi tradizionali di cura
- **Governance centralizzata ed erogazione decentralizzata**

Modello di finanziamento:

Servizio è interamente finanziato dalla Provincia ed è fornito gratuitamente agli utenti. Investimenti iniziali su: i) infrastruttura tecnologica; ii) piattaforma digitale



Università
Bocconi

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

SDA **Bocconi**
SCHOOL OF MANAGEMENT

Casi di studio internazionali

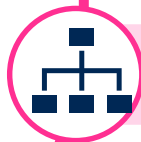
etxeTIC. Biscaglia, SPAGNA



Forte commitment istituzionale



Equilibrio tra standardizzazione e flessibilità



Coordinamento multilivello



Tecnologia come abilitatore



**Università
Bocconi**

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

Criticità emerse:

- Necessario cambiamento culturale tra professionisti
- Usabilità, accessibilità e costi delle soluzioni tecnologiche
- Scarsa automazione dello scambio digitale di informazioni tra centri ed ente pubblico, nonché standardizzazione dei processi di lavoro

Casi di studio internazionali

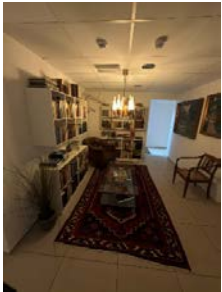
Dagmarsminde. Græsted, DANIMARCA



Small-scale living per persone con demenza

Struttura residenziale di **piccole dimensioni** per persone con demenza grave, organizzata come una casa, che ospita fino a 12 residenti («oasi di cura»).

Obiettivo: promuovere un **approccio relazionale** alla cura, con forte riduzione dell'uso di farmaci e valorizzazione della vita quotidiana, delle relazioni e di una dimensione domestica degli spazi di cura offerti.



Piccoli team (2 operatori per turno)

Gerarchia piatta ed elevato grado di autonomia

Stile di leadership basato sull'esempio e sulla prossimità

Routine strutturate (sicurezza, prevedibilità)

Attività di gruppo + individuali ma inserite in routine collettiva

Geriatra garantisce supervisione clinica (ogni 3 settimane)



Università
Bocconi

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

SDA Bocconi
SCHOOL OF MANAGEMENT

Casi di studio internazionali

Dagmarsminde. Græsted, DANIMARCA

Elementi strategici

- **Piccola scala:** qualità della relazione, gestione efficace delle dinamiche di gruppo e sostenibilità operativa.
- **Modello integrato:** superamento della separazione fra abitare, cura e vita comunitaria,.
- **Non-medicalizzazione:** si privilegia un approccio relazionale e centrato sulla quotidianità.
- **Diversa allocazione delle risorse** (umane, di spazio) esistenti, definite dalla regolamentazione del sistema pubblico.

Modello di finanziamento:

- Finanziamento Comunale (sistema pubblico danese di LTC) analogo a quelli delle strutture residenziali tradizionali.
- I residenti contribuiscono direttamente ai costi di alloggio, vitto e servizi accessori.
- Per lo sviluppo e la scalabilità del servizio, sono stati coinvolti investitori privati, in particolare nella fase di espansione (3 nuove strutture apriranno a breve).



Università
Bocconi

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

SDA Bocconi
SCHOOL OF MANAGEMENT

Casi di studio internazionali

Dagmarsminde. Græsted, DANIMARCA

Università
Bocconi**CERGAS**Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

Criticità emerse:

- Iniziale resistenza del personale proveniente da strutture tradizionali
- Replicare il modello richiede preservare filosofia di cura e cultura organizzativa
→ ruolo centrale della leadership nell'accompagnare il personale nel passaggio a un nuovo modo di lavorare e mantenere coerenza nei valori e

Casi di studio internazionali

Sintesi elementi chiave

Caso	Elementi strategici	Fattori abilitanti	Barriere e criticità
SällBo	Housing come piattaforma sociale; mix di target deliberato	Crisi migratoria 2015; disponibilità di edificio da riqualificare	Dipendenza da figure chiave; scalabilità; complessità matching
Maison Biloba	Case management e permeabilità a quartiere	Approccio incrementale (sperimentazione) e community-based	Finanziamento frammentato; difficoltà riconoscimento modello
Trygghetsboende	Supporto sociale leggero + abitare accessibile (no cura)	Coerenza con welfare esistente; semplicità modello	Targeting debole; ingresso tardivo; rischio deriva assistenziale
Thuisplusflats	Coordinamento tra housing e care; unico provider servizi	Incentivi economici; governance locale; équipe integrate	Incentivi divergenti; disallineamento costi-benefici
Home with Care	Integrazione housing + care (livello intermedio)	Sviluppi normativi relativi alla pianificazione urbana (edilizia sociale mista)	Standard a-specifici, cicli finanziamento brevi (instabilità)
etxeTIC	Architettura di servizio ibrida; equilibrio fra centralizzazione e decentralizzazione	Tecnologia; accesso remoto; integrazione servizi	Digital divide, usability; flussi informativi
Dagmarsminde	Small scale; approccio umanistico e personalizzato	Cultura organizzativa; innovazione operativa isorisorse	Capacità di replicare valori più che layout

**Bocconi**

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

SDA Bocconi
SCHOOL OF MANAGEMENT

LONG TERM CARE IN TRASFORMAZIONE: CASA, SERVIZI E COMUNITÀ

**DOVE SI GIOCA L'INNOVAZIONE DEI MODELLI DI SERVIZIO?
LEZIONI DALLE ESPERIENZE INTERNAZIONALI**

Andrea Rotolo

**Presentazione dell'8° Rapporto
OSSERVATORIO LONG TERM CARE**



Universit 
Bocconi

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

SDA Bocconi
SCHOOL OF MANAGEMENT

Casi studio internazionali

Ripartire dai **bisogni**



Domicilio



Residenzialità istituzionale

Bisogno di **modelli intermedi** che rispondano ad alcuni **bisogni**

- Solitudine e isolamento sociale
- Prolungamento autonomia (*ageing in place*)
- Integrazione sociale e culturale
- Accompagnamento e orientamento
- Supporto leggero ma continuativo
 - Supporto relazionale

Costruzione
del servizio
**attorno ai
bisogni**



Università
Bocconi

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

Casi studio internazionali

Come si fa l'innovazione?

I percorsi per arrivare all'innovazione:

- **Incrementali** (adattamento di soluzioni esistenti)
- Tramite **sperimentazioni locali**
- Raramente **codificata ex ante**, ma emergente
- **Co-progettazione con utenti e stakeholder** (logiche **bottom-up** o **ibride**)



Università
Bocconi

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

SDA **Bocconi**
SCHOOL OF MANAGEMENT

Casi studio internazionali

Elementi di innovazione

- **Target di utenza** → mix di popolazioni (generazionale / sociale / culturale) e bisogni
- **Figure professionali e competenze** → Community Manager / Host / Coordinator (quali competenze servono?)
- **Infrastrutture e dimensione comunitaria** → lo spazio come elemento «core» in molti modelli di servizio (progettazione intenzionale) + relazioni come «infrastruttura di cura»
- **Rete dei servizi** → integrazione con sistema sanitario / sociale / territoriale
- **Ruolo degli utenti** → partecipazione e corresponsabilità
- **Operatività dei servizi** → flessibilità per garantire adattamento continuo ai bisogni
- **Sostenibilità economica** → combinazione di risorse pubbliche + private + utenti



Università
Bocconi

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

Casi studio internazionali

Le sfide e le criticità

Prospettiva provider

- La sfida della scalabilità
- Sostenibilità economica
 - Mismatch tra target teorico e reale
 - Il ruolo (limitato) dell'innovazione digitale

Prospettiva Policymaker

- Integrazione servizi innovativi con il sistema pubblico «tradizionale»
- Limiti regolatori (modelli ibridi)



Università
Bocconi

CERGAS
Centro di Ricerche sull'
dell'Assistenza Sanitari



SDA Bocconi
SCHOOL OF MANAGEMENT

Casi studio internazionali

Quali spunti di lavoro?

- Spostare il focus dalle singole prestazioni all'**ecosistema di supporto e all'infrastruttura come piattaforma**
- Investire su nuovi **ruoli ibridi** (community manager, host, case manager evoluti) che siano «connettori»
- Progettare servizi a partire dai **bisogni sociali**, non solo sanitari (che spesso vanno di pari passo)
- **Forte integrazione** con altri servizi formali + reti informali
- Lavorare su **partnership multi-attore** (pubblico, privato, comunità)
- **Anticipare il bisogno**: ingresso precoce nei modelli (pre-fragilità)
- Attenzione a **selezione e matching** degli utenti



Università
Bocconi

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

COSA SERVE PER INNOVARE I SERVIZI LONG TERM CARE OGGI? IL PUNTO DI VISTA DEGLI ESPERTI.

Mariuccia Rossini, Presidente Silver Economy Network e Over

Dragana Curovic, Project Manager Helsingborgshem, Città di Helsingborg, Svezia

Ranieri Antonio Zuttion, Direttore Area Welfare di Comunità, Regione Friuli Venezia Giulia

Modera:

Francesco Longo, Università Bocconi



**Università
Bocconi**

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

LONG TERM CARE IN TRASFORMAZIONE: CASA, SERVIZI E COMUNITÀ

**PUNTI FERMI E AMBITI DI
SPERIMENTAZIONE PER AFFRONTARE
LE CRITICITÀ DELLA LONG TERM CARE.**

Giovanni Fosti

**Presentazione dell'8° Rapporto
OSSERVATORIO LONG TERM CARE**



**Universit 
Bocconi**

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

SDA Bocconi
SCHOOL OF MANAGEMENT

LONG TERM CARE IN TRASFORMAZIONE: CASA, SERVIZI E COMUNITÀ

**UNA PROSPETTIVA EUROPEA
SUI MODELLI DI SERVIZIO POSSIBILI.**

Presentazione dell'8° Rapporto
Osservatorio Long Term Care

6 maggio 2026



**Università
Bocconi**

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

SDA Bocconi
SCHOOL OF MANAGEMENT